本章数字资源

第四章 全科医生的临床诊疗思维

学习提要

- 扎实的医学知识和丰富的临床实践是全科医生临床诊疗思维的基础。
- 临床思维包括临床收集资料过程、分析资料作出诊断的过程和通过观察病情的发展及治疗对诊断的检验和修正的过程。
- 以病人为中心的系统思维模式、以问题为导向的诊疗思维模式、以证据为基础的临床思维模式构成了全科医生临床思维特征。

全科医生主要是在基层开展全科医疗服务的临床医生，为社区居民提供以病人为中心、家庭为单位、社区为基础、预防为导向的连续性、综合性、协调性、整体性、个体化、人性化及一体化的医疗保健服务。一名优秀的全科医生不仅需要扎实的医学理论和丰富的临床经验，其职业特点更要求其必须掌握系统整体性的思维方式，在实践中整合各临床专科以及行为科学、自然科学和社会科学等学科的知识、技术，为居民提供全面、合理的全科医疗服务。

第一节 | 概 述

一、临床思维的概念

思维（thinking）是指在表象（感知过的客观事物在人脑中重现的形象）和概念基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程。临床思维（clinical thinking）是临床医生利用医学科学、自然科学、人文社会科学和行为科学的知识，对临床资料进行综合分析、逻辑推理，从错综复杂的线索中找出主要矛盾并加以解决的过程。临床思维贯穿于疾病诊断与处理的全过程。

临床思维不是脱离实际的凭空猜想，必须具备两个基本条件，即扎实的医学知识和丰富的临床实践，两者缺一不可。所谓医学知识，是指基础医学知识和临床医学知识。作为一名全科医生，除医学知识，还应主动了解自然科学和社会科学知识、生活知识等。这些知识看似与诊断疾病并没有直接关系，但实际上随时可能有助于拓宽全科医生的诊断思路。所谓临床实践，包括直接和间接实践。直接实践即深入临床接触患者，通过问诊、体检和诊疗操作等参与患者的诊治，细致而周密地观察病情，发现问题、分析问题和解决问题；而间接实践则通过阅读医学文献、参加临床病例讨论会等，从他人的临床实践中获取经验或教训。临床实践离不开仔细的临床观察、经验的积累和理论的补充。临床医生通过实践获得的资料越翔实、知识越广博、经验越丰富，临床思维过程就越快捷，也就越能快速作出正确的诊断与合理的处置。没有大量的临床实践不可能积累丰富的经验，也无法进行科学的临床思维。

二、临床思维的要素

临床思维一般可分为三个阶段，即临床收集资料过程、分析资料作出诊断的过程和通过观察病情的发展及治疗对诊断的检验和修正的过程。获取真实、系统、完整、准确的临床资料是临床思维的必备要素。临床资料收集过程包括病史采集、体格检查及获得实验室和辅助检查资料。

NOTES

（一）病史采集技巧

病史是从患者那里直接获得的第一手资料，也是医生进行临床思维的依据。医生收集病史的过程是其充分运用自己所学的知识，调动全部感知能力，筛取各种可能有意义的病史资料，进行即时分析、思考的过程。在全科医疗中，病史对于明确诊断至关重要，可根据病史对 80% 的问题作出诊断。全科医生采集病史不是简单地听患者讲述和记录，也不仅仅是按照某种表格的顺序进行询问和填写，而是应该充分运用所有知识，调动全部感知能力，注意患者的面部表情、语气语调及姿势等变化，梳理出对诊断有意义的重要线索，进行即时分析、思考。采集病史的过程，医生不仅要了解疾病，还要了解患者本身，包括社会特性和个人性格，这个过程也为建立理想的医患关系奠定基础。

（二）认真细致的体格检查

通过采集病史，全科医生对病情有了一定了解，并有了初步的诊断设想，但对这些诊断是否能成立还难以确定，而体格检查则是对病史资料遗漏或不足的补充。通过体格检查，从患者身上寻找阳性或阴性体征，可使诊断思维更加接近实际病情。

体格检查的要求是既要全面系统又要有重点。所谓重点，是指在收集病史过程中发现的疑点要重点检查，对与疑点有关的体征作出有把握的肯定结论，无论是阳性还是阴性，都对诊断有重要的意义；而全面系统检查则可以避免重要部位的遗漏。如直肠肿瘤是临床上容易通过直肠指检就能进行诊断的疾病，但是临床医生往往对直肠指检的重要性认识不足，导致了直肠肿瘤的漏诊和误诊。需要注意的是在临床上由于体格检查结果受疾病变化的影响，因此当病情有变化时应再次进行体检。

（三）正确判断实验室和辅助检查的意义

实验室和辅助检查是病史和体格检查的延伸。虽然有些疾病可通过病史及体格检查作出诊断，但选择合适的实验室和辅助检查有助于进一步支持诊断，使诊断更加可靠、完善和客观。对于诊断困难的病例，也需要相应的实验室和特殊检查来协助诊断。全科医生要对各种常规检查的灵敏度和特异度有充分的了解，在判读检查结果的临床意义时，须同时考虑患者和实验室两方面的因素。如血清淀粉酶的升高对于急性胰腺炎的诊断有较高的灵敏度，但并不具备特异性，其测定值的大小与起病时间有关，如果全科医生缺乏这方面的知识，有可能会导致错误诊断。同时由于各种检查都存在一定的局限性，不能代替医生对患者的细心观察、体格检查和思考，因此既要全面理解和分析各种检查结果，也要注意与临床实际相结合。

由于某些疾病的病情是动态发展的，因此作出临床诊断后，还要不断验证。对于诊断不明确、治疗效果欠佳者，需要不断地思考，寻找可能的原因，并且注意动态观察病情变化，通过补充问诊、仔细反复体检及必要的辅助检查来验证诊断。临床思维不是一次完成的，而是一个反复观察、不断思考、充分验证的动态过程。

三、临床思维方法

一个正确诊断或治疗方案的确立除了要求全科医生掌握诊疗疾病的基本理论、基本技能并且具备临床经验外，还必须具备正确的临床思维方法。临床思维虽然有许多方法，但没有固定的模式，在临床工作中通常是几种方法一起使用，互相补充。

（一）推理法

推理是临床医师获得临床资料或诊断信息之后到形成结论的中间思维过程，包括假设演绎推理、归纳推理和类比推理。

1. 假设演绎推理　是指在观察和分析的基础上提出问题以后，通过推理和想象提出解释问题的假说，根据假说进行演绎推理，再通过实验验证演绎推理的结论，从而比较患者的临床表现是否符合诊断标准。这是临床上最常用的一种临床思维方法。

假设演绎推理法通常先将患者的临床资料进行整合，找出主要问题，通过推理和想象提出可能的诊断假设。如患者有渐进性的活动后胸闷、气促伴少尿及双下肢水肿，推理出其患有右心功能不全的

可能性诊断假设；如果在体格检查的时候发现颈静脉怒张、肝肿大、肝颈静脉回流征阳性的体征，那么患者诊断为右心功能不全的假设就获得了更多的证据支持，诊断也就更为可靠。而患者的辅助检查如心脏超声提示右心室扩大，N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）明显升高，则该诊断假设的概率就高。如果再经过治疗试验，按照右心功能不全治疗后患者症状、体征明显好转，就说明诊断假设是正确的；反之，则说明诊断假设是错误的。假设演绎推理的诊断程序见图 4-1。

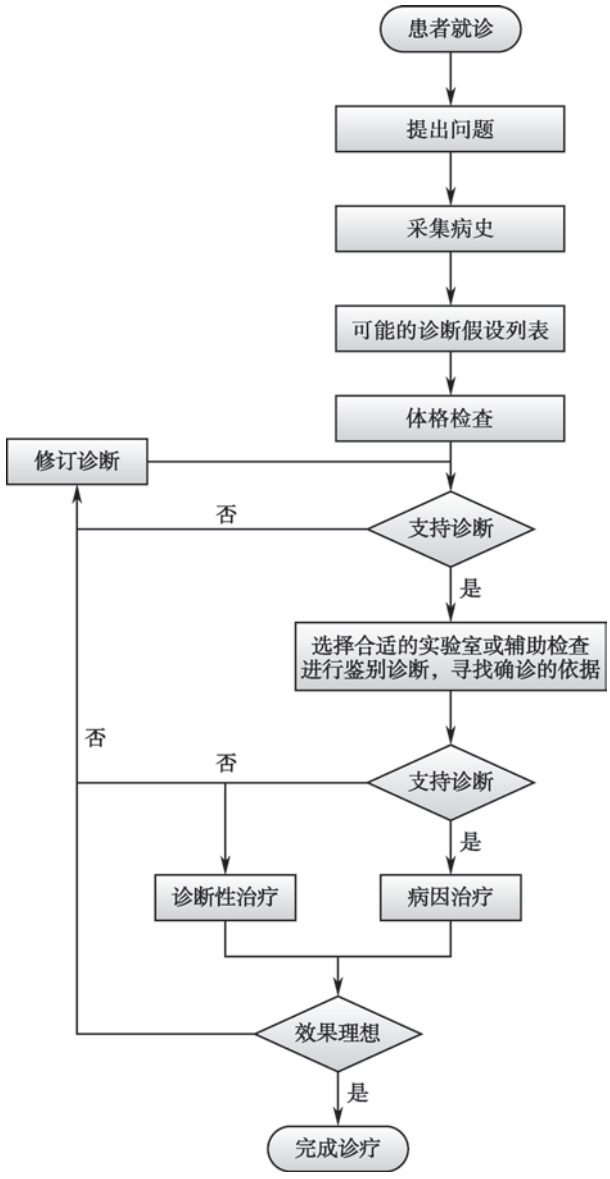


图 4-1 假设演绎诊断程序

尽管假设演绎推理法是一种高效的临床诊断策略，但因其对于假设和检查项目的数目不加限制，有可能导致医疗资源的过度使用。为了适应社区居民健康“守门人”角色的要求，全科医生的临床思维应该是一种有限制的假设演绎过程，即利用低成本的诊疗手段获取最佳的健康效果和最大的经济效益。因此，更强调物理诊断、临床思维或判断能力，并在其中渗透生物-心理-社会医学模式。

2. 归纳推理 是一种从个别和特殊的临床表现推导出一般性或普遍性结论的推理方法。医生所搜集的每个诊断依据都是个别的，根据这些诊断依据提出临床初步诊断，就是由个别上升到一般，由特殊性上升到普遍性的过程和结果。如弗莱明在一次意外中发现了青霉素，而经过弗洛里和钱恩的一系列临床试验，发现使用青霉素后不同患者的炎症均被消除了，于是得出结论：这种后来被命名为盘尼西林的药物，对链球菌、白喉棒状杆菌等多种细菌感染有显著疗效。

3. 类比推理 两个或两个以上疾病在临床表现上有某些相同或相似之处，但也有不同之处，经过比较、鉴别、推理而确定其中一个疾病，这种方法就是类比推理。类比推理是临床医生认识疾病的重要方法之一，临床上常常应用该方法来进行鉴别诊断。如实验医学的开拓者哈维，通过对人体心脏与水泵的类比分析，揭示了血液循环的奥秘。而 18 世纪奥地利的奥恩布鲁格运用类比推理法，将“酒桶和装酒量”与人的“胸腔和胸腔积液”进行类比，反复探索胸部疾病与叩击声音之间变化的关系，最终发明了叩诊这一方法。

（二）横向列举法

横向列举是根据临床表现及实验室等检查结果考虑各种可能的疾病，通过查找诊断依据或进一步选择其他检查，逐步将思维引导到正确的方向，或逐步缩小诊断范围，直到明确诊断。如先确定是哪一系统的疾病，再推测是该系统中哪个器官的疾病，然后再确定病变的范围和性质，最后通过进一步检查明确诊断。横向列举是一种横向的、向空间发展、向四面八方扩散的思维，是对问题本身不断地提出问题、重构问题，并且不断探究、观察事物的不同方面的思维。如患者因咯血而就诊，而咯血的

NOTES

原因很多，如支气管扩张症、结核、肺肿瘤、肺脓肿、肺部炎症等，再通过仔细询问病史得知其有反复咳嗽伴咳黄脓痰病史 20 余年，推测其咯血的原因可能为支气管扩张，进一步行影像学检查后证实诊断。

（三）模型识别法

模型识别就是典型患者的识别，是对与已知疾病的图像或模型相符合的患者问题的即刻辨认。这种诊断方法仅靠观察患者便可得出，但只有在患者症状典型、符合唯一的疾病模型时，才能使用此种方法，如临床上典型的甲状腺功能亢进的患者，可以采用模型识别法进行诊断。但是临床上大部分患者的症状并不典型，因此模型识别法的应用非常有限。

第二节 | 全科医学临床思维特征

全科医学临床思维的基本特征主要体现在以下几方面：以病人为中心、以问题为导向、以证据为基础的临床思维；体现生物-心理-社会医学模式；遵循辩证思维、逻辑思维的基本认识规律；坚持科学的批判性思维。

（一）以病人为中心的系统思维模式

以病人为中心的照顾是全科医疗的基本特征，与专科医疗的以疾病为中心的诊疗模式有着根本的区别。而以病人为中心的临床思维方式也是与以疾病为中心的临床思维方式相对应的。以疾病为中心的临床思维是一种集中思维，相当于用显微镜去观察物体；而以病人为中心的临床思维却是一种发散思维，相当于用望远镜去观察物体。前者更注重实质，而后者更注重背景和关联。以病人为中心的诊疗思维模式是以人的整体健康为最终目标，患者的需求和期望与生理疾病同等重要。实际上，专科医生与全科医生之间非常需要合作，在专科医生对疾病进行深入、细致的分析之后，就需要全科医生对各种问题进行全面、系统的整合。以病人为中心的系统思维具有以下特点。

1. 充分了解患者　希波克拉底曾说过：“了解你的患者是什么样的人，比了解他们患了什么病要重要得多。”以病人为中心的系统思维基本特点是进入患者的世界、了解患者的个性。当面对一个患者时，专科医生首先想到的是其所患的疾病，而全科医生以病人为中心的系统思维则使其首先考虑的是了解患者。全科医生可以使用系统整体性的问诊来了解患者的背景，包括个人背景、家庭背景、社会背景、疾病背景等。当患者的问题无法用生物医学的原理来解释时，或当患者因轻微的症状而反复就诊时，更应仔细询问患者的背景。因为在进行许多决策过程中，与患者健康相关的价值观和情境可以与生理资料同等甚至更加重要；而且心理、社会和情境问题显然会影响到患者的生物学疾病，对心理社会问题的探查也会为以病人为中心的全科医生提供许多潜在的线索。

2. 关注患者的就医背景　全科医生使用的模式有别于生物医学模式之处，在于其不仅追求生物学问题的诊断，还要回答另外一种问题，即患者为什么要来看病，也就是关注患者的就医背景。在就医背景中，全科医生需要了解以下几方面内容：患者就医的原因、患者就诊的期望、患者的需要、患者的疾病因果观、患者的健康信念模式、患者的患病体验和患病对患者生活的影响或意义。全科医生只有充分了解患者的就医背景，才能更深入地了解患者，与其建立一种持续的密切的医患关系；为其制订个性化的长期的健康管理计划，并在实施计划过程中不断提高其遵医性。

3. 以生物-心理-社会的医学模式确认现存问题　生物-心理-社会医学模式是以人的整体健康为最终目标，疾病是患者的一部分而并非全部，患者的需求和期望与生理疾病同等重要。全科医生通常采用生物-心理-社会的医学模式来确认现存问题。首先从生物医学的角度跨学科、全面、综合地考虑服务对象的健康问题与疾病的诊疗，考虑有问题的器官系统与其他相关器官系统间的相互关系、局部与全身的临床表现及相互影响。其次从生物医学领域延伸到患者领域，了解患者的患病体验、患病行为等，深刻理解患者。如一位高血压患者因近期血压控制不佳而来就医，全科医生除了要给予降压治疗，还要深层次地探索血压控制不良背后是否隐藏着其他的原因，如是否有什么其他诱因导致血压升高、有无生活压力、情绪如何、是否坚持服药、该疾病对其生活有多少影响、有无顾虑、希望医生给予

什么样的帮助等，即从心理层面、社会层面分析（图 4-2）。

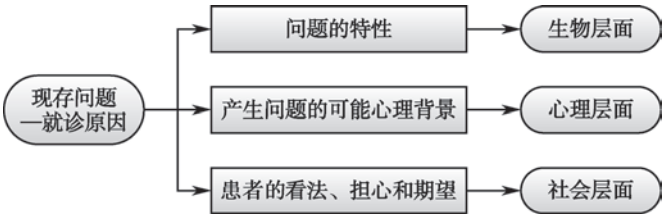


图 4-2 以生物-心理-社会医学模式确认现存问题

4. 体现全人照顾的特点 以病人为中心的系统性思维体现了全科医学全人照顾的要求，即照顾完整的人、全面的家庭照顾、连续性的照顾和多学科的全面照顾。全科医生不仅服务于来就诊的患者，也服务于未就诊的患者，同时服务于患者和健康人，还服务于家庭和社区；全科医生不仅负责疾病的诊疗，也负责疾病的预防、保健和康复；不仅治疗疾病，也治疗患者；不仅关心躯体的疾病或疾患，也关心心理、社会、道德、伦理等方面的问题；不仅关心现存的问题，更关心未来的问题，注重防患于未然。因此全科医生不能只局限于医学领域，而是应将社会学和人文学等相关领域的内容纳入到全科医生临床思维体系中，对患者的社会、经济、文化、心理各个方面的因素加以考虑，帮助患者解决实际的问题。

总之，全科医师要以病人为中心的系统思维去了解患者所患的疾病，更要了解所患疾病的人。在健康服务的过程中，全科医师不是旁观者和指挥者，而是与患者处于平等地位，作为医患互动共事的一部分而发挥作用，是维护人的整体健康和提高人的生命质量的艺术家。

（二）以问题为导向的诊疗思维模式

以问题为导向的诊疗思维是以发现和解决个人、家庭、社区的疾病与健康问题为导向，综合运用临床医学、预防医学、心理学与社会学等学科的相关方法，对各种问题进行诊断，了解其产生的原因及影响因素，确定健康需要，制订和实施相应的诊疗措施，以实现对各种疾病与健康问题的有效治疗和照顾。是一种以问题的发现、分析、诊断和处理为主线的疾病诊疗和健康照顾过程，强调以疾病与健康问题的发现和诊断为出发点，以问题的妥善处理、以个体和群体的健康维护和健康促进为目标，并将以问题为导向的思维贯穿于整个服务过程中。全科医学涉及的内容中，常见病多于少见病及罕见病；健康维护问题多于疾病诊治；研究整体重于研究细胞，因此以问题为导向的诊疗思维非常重要。

在基层医疗卫生保健服务中，大部分疾病尚处于早期未分化阶段，绝大多数患者都是因症状或健康问题而不是因疾病就诊。有些症状是一过性的症状，往往无须也不可能作出病理和病因学诊断；有些症状则可能是由心理社会因素引起的；而有些症状仅属于健康问题，尚不属于疾病的范畴；但也有许多症状可能是一些慢性病和严重疾病的早期症状。全科医生最重要的工作就是对产生症状的最可能病因作出诊断，同时排除严重的疾病。因此对于全科医生来说，在临床诊疗中应更强调患者的症状、体征、诊断性试验等检查结果，以及与疾病和健康有关的心理、社会、经济、文化等方面的问题。从主诉、症状、体征和问题入手来进行诊疗思维是全科医生的工作特征，也是其认识和处理未知疾病的基本思路。同时全科医生必须掌握各种疾病的诱因、流行病学、自然过程和临床表现方面的知识，以确保问题的及时发现和准确诊断。

以问题为导向的诊疗思维模式，要求全科医生始终围绕疾病与健康问题，准确分析和识别常见病的一般性症状和特异性症状，并善于从患者主诉的一系列问题中分清主要问题和次要问题，善于把握问题的实质，从系统的角度全面分析各种症状信息，从而避免可能发生的误诊。此外，由于疾病的发生、发展往往要经历一个相对漫长的自然进程，疾病症状表现的多样性使得人们很难在初期找到疾病的特异性症状并作出准确的诊断，因此全科医生在疾病处理过程中应遵循全面性、联系性和系统性的原则，充分利用与患者之间形成的相对稳定的医患关系，动态、渐进地观察、跟踪疾病和健康问题的变化，及时收集各种相关信息，以调整和修正自己的最初判断和对疾病的处理方案。

（三）以证据为基础的临床思维模式

以证据为基础的临床思维模式是一种科学的思维模式和临床决策方法。临床医学是证据科学和经验科学的结合，全科医生通过从众多的医学资源中寻找最佳的证据，从而为患者提供更好的诊疗和健康照顾。

以证据为基础的临床思维模式可以分为 5 个步骤，概括起来称为“5A 程序”，即提出问题（ask）、寻找证据（acquire）、评价证据（appraise）、应用证据（apply）和评价结果（assess）。第一步是从临床工作中提出问题，如患者的治疗措施、治疗效果都可以作为问题提出来；第二步，寻找证据，书籍、文献、网络通常都是寻找证据的途径，可以充分利用循证医学的证据；第三步，评价证据，对证据的可信度、重要性和实用性进行评价；第四步，应用证据，将目前获得的最佳、最新的证据应用于工作中；第五步，评价结果，对最佳证据应用于临床后的结果进行评价。以上 5 个步骤不断循环，从而促进科学临床思维的形成与发展，提高全科医生的临床诊治水平。

第三节 | 全科医疗中常见的健康问题及特点

一、社区常见健康问题

社区居民的健康问题种类繁多，但常见的问题却相对集中。全科医疗中临床常见的问题有：呼吸系统、消化系统、泌尿系统等的常见感染；高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性非传染性疾病；吸烟、酗酒问题；超重与肥胖问题；营养不良问题；记忆力减退问题；优生优育问题；青少年妊娠问题；计划免疫问题；各种预防保健问题和各种健康教育问题；经济、社会、家庭的其他问题等。此外，全科医生还要面对大量常见症状、疾病的诊断、治疗和干预等问题。

全科医疗中常见的 30 种症状占所有常见症状的 85% 左右，分别是：咳嗽或咳痰、流涕、咽痛、发热、耳鸣、消化不良、腹痛、腹泻、便秘、肩部疼痛、腿疼或痉挛、腰背痛、胸痛、皮疹、皮肤瘙痒、白带增多或瘙痒、月经异常、眼部疼痛或不适、心悸、失眠、头晕或眩晕、头痛、便血、气短、视力障碍、泌尿道症状、疲劳（乏力）、体重减轻、指/趾甲问题、局部肿块。

全科医生所遇到的疾病的种类和分布取决于其服务的人口特征和社区环境。下面列出了全科医疗中最常见的各系统的疾病，覆盖了基层医疗保健中诊断的前 80% 的疾病。全科医生应能够很好地诊断和处理这些疾病。

1. 呼吸和耳鼻喉系统　上呼吸道感染（病毒性或细菌性）、过敏性鼻炎、哮喘、慢性阻塞性肺疾病、耳道炎（急性、慢性）、鼻窦炎。

2. 心脑血管系统　高血压、冠心病、心力衰竭、脑血管意外。

3. 消化系统　胃肠炎（病毒性、细菌性，急性、慢性）、便秘、肠易激综合征、消化不良、结肠炎（溃疡性或非溃疡性）、痔。

4. 泌尿生殖系统　尿道感染、阴道炎（真菌性、萎缩性阴道炎等）、功能性子宫出血、绝经综合征、良性前列腺增生。

5. 神经系统　头痛（偏头痛、紧张性头痛等）、头晕或眩晕、压迫综合征（如腕管综合征）。

6. 肌肉骨骼系统　肌肉及软组织损伤、关节炎（骨关节炎、类风湿关节炎、痛风）、脊柱退行性疾病（颈椎病、腰椎病）、肩部综合征（如肩周炎、疼痛性弧综合征）、腱鞘炎（如扳机指）。

7. 内分泌系统　糖尿病、甲状腺疾病、骨质疏松症。

8. 精神心理问题　抑郁、焦虑、依赖（包括烟草依赖，酒精依赖、药物依赖、互联网依赖等）、精神病等。

9. 恶性肿瘤　胃癌、结肠癌、乳腺癌等。

10. 皮肤　皮肤感染（细菌性、病毒性、真菌性）、湿疹、过敏性（如荨麻疹、药物反应等）、痤疮。

NOTES

二、社区常见健康问题的临床特点

全科医生在社区中要面对各种健康问题，与专科医生相比，全科医生面对的常见健康问题有如下特点。

1. 大部分健康问题处于疾病的早期和未分化阶段 在疾病和健康问题的早期，多数患者只是感觉不适，或者只有一些症状和不典型的体征，但还未出现明确的疾病证据；或仅表现为情绪低落、性情暴躁、记忆力减退等。这时，患者极少主动就医，更不可能去专科医生那里就医。但这一阶段往往是全科医生进行干预的最佳时期，所花费的成本最小，收效却最大。因此，全科医生应特别关注对早期未分化健康问题的及时发现和处理，并努力掌握相关的知识和基本技能。

2. 常伴随大量的心理、社会问题 躯体疾病可以伴随大量的心理、社会问题，精神疾患也可以伴随许多躯体症状，两者常互为因果。许多患者有明显的躯体症状，却没有明显的阳性体征和实验室检查结果，难以作出明确的躯体疾病诊断。心理、社会问题既可以是躯体疾病的原因，又可以是躯体疾病的表现，反之亦然。因此全科医生必须善于识别和处理这一类问题，并且具备从生理、心理、社会维度对疾病或健康问题进行诊断的知识和技能，能够从问题的生物源性、心理及社会源性着手，对问题进行分析、鉴别及有效的干预。

3. 疾病和健康问题具有很大的变异性和隐蔽性 专科医生诊治的通常是一类疾病，往往相对固定，变异性不大。而全科医生则面对的是其所服务社区所有居民的疾病和健康问题，涵盖了不同年龄、性别、不同部位的疾病，以及各种生理、心理、社会原因导致的健康问题和疾病。因此，其面对的疾病和健康问题具有很大的变异性。此外，受个人健康意识、对疾病的重视程度以及症状轻微等多种因素的影响，在疾病的早期和未分化阶段人们很少主动就医，其健康和疾病问题很容易被忽视，使得其健康问题具有很大的隐蔽性。因此，要求全科医生不断追踪和动态了解其服务社区中的个人、家庭的健康档案和信息，了解各种疾病和健康危险因素的流行状态，掌握各种疾病的诱因、流行病学、自然过程和不同的临床表现等方面的知识，通过对多方面知识和技能的掌握，有效应对潜伏隐匿、充满变异和不确定性的健康问题。

4. 慢性疾病多见，就诊频率高 慢性疾病占据了社区常见疾病谱的前几位，其往往需要全科医生提供连续性、综合性的医疗保健服务。慢性疾病患者就诊频率高，因此是全科医生日常服务的主要对象。对于这些患者而言，重要的不是治愈疾病，而是如何预防疾病的发生、发展，并且适应环境的变化。

5. 健康问题的成因和影响常是多维度和错综复杂的 现代疾病谱中的很多疾病既不是纯生物性的，也不是纯心理或社会性的，而是生物、心理、社会诸因素不断交叉累积、相互作用的结果。社区中健康问题的原因和影响可能涉及生物、躯体、心理、个人、人际关系、家庭、社区、社会文化、宗教、政治、经济等多种因素和多个方面，以上因素之间又存在错综复杂的相互作用。如果不了解这些因素之间的相互关系和作用，就难以把握疾病问题的整体特性，也难以全面、有效地解决这些问题。全科医生对健康问题的关注，不仅仅局限于某一器官和系统疾病，而是重视各系统之间，身体与精神之间，生理、心理、社会问题之间的相互关联，以及个人的疾病与其家庭、工作单位、社区环境之间的密切联系。

6. 健康问题多于疾病、常见病多于罕见病 虽然全科医生面对的疾病和健康问题具有广而杂的特点，但是，由于现代社会中导致疾病的危险因素（如吸烟，饮酒，高热量、高脂肪膳食，肥胖，缺乏运动等各种不良行为和生活方式等危险因素）的广泛流行及大量积聚，使得大量健康危险因素以及健康相关问题的处理成为全科医生日常工作的重要内容。总体上讲，全科医生面对的疾病和问题中，常见病多于少见病及罕见病，健康问题多于疾病。因此全科医生不仅要掌握处理各种常见病、多发病的知识和技能，还要学会社会学、心理学、行为学、人际沟通和传播学等各种相关知识和技能，善于寻找和摸索改善人们长期以来的各种不良生活和行为方式的有效策略，从而真正将各种疾病的危险因素及时

消除，实现主动预防和干预的目标。

三、社区常见健康问题的诊断策略

全科医生在社区中所接触的健康问题大多处于未分化的早期阶段，而且社区中多缺乏高级的辅助检查设备，因此，及时作出明确的疾病诊断有时可能较为困难，这就要求全科医生在鉴别健康问题的性质或诊断疾病时，采取独特的临床诊断策略，运用逻辑思维和辩证思维，全面系统地认识和处理各种健康问题，运用动态、联系和发展的眼光来看待各种疾病与问题的发生、发展和相互转化的过程。

（一）全科医生的诊断方法

1. 病因的初步诊断方法　全科医生作为基层医生，最重要的作用就是对产生症状的最可能的病因作出初步诊断，同时排除严重的疾病。基本步骤是：①耐心倾听患者陈述症状；②了解症状的性质（特点、加重和缓解的因素）和病程特点（急性、反复发作或慢性）；③判断患者的症状是否提示其正处于危及生命的紧急情况，如是否存在呼吸困难、休克等严重情况，是否需要正确处理后紧急转诊；④根据患者的症状和个人信息，如年龄、性别、既往史和家庭背景等，列出一系列可能会导致该症状的鉴别诊断（通常 2~5 个）；⑤根据对所列举的鉴别诊断的特定症状和体征的了解，进一步收集病史，进行适当的体格检查，以确认最可能的诊断，并排除其他诊断；⑥当诊断不明或需要排除潜在的严重疾病时，须进一步选择实验室和辅助检查，必要时转诊。

2. 掌握基本的临床诊断思维方法　基本的临床诊断思维方法包括从症状入手的诊断思维方法、从疾病入手的诊断思维方法和从系统入手的诊断思维方法，其中最常用的是以症状入手的诊断方法。症状是患者就诊的主要原因，同时也是疾病的基本信号和线索，因此，从患者主诉的症状、体征着手进行疾病诊断是最为常用的诊断思维方法，也最符合临床认知规律。该方法包括刻画诊断法、归缩诊断法、菱形诊断法和诊断三联征（diagnostic triad）等多种方法。其中诊断三联征主要由具有疾病识别特征的 3 个关键症状和体征构成，是全科医生基于症状和体征对疾病快速识别和诊断的常用方法之一。

典型的诊断三联征举例如下。

发热 + 头痛 + 颈项强直 → 脑膜炎

腹痛 + 寒战高热 + 黄疸 → 急性胆管炎

腹痛 + 停经 + 阴道异常出血 → 异位妊娠

月经失调 + 肥胖 + 多毛症 → 多囊卵巢综合征

3. 实施临床推理的基本方法　包括穷极推理法和假设演绎推理等方法。穷极推理法是在全面询问病史、完整的体格检查以及常规的实验室检查等系统回顾后，进行归纳推理，以得出可能的诊断，而在得出推理之前不做任何假设；假设演绎推理是根据患者的最初线索快速形成诊断假设，然后根据诊断假设选择并实施各项临床检查和实验室检查项目，进而依据检查结果对诊断假设进行归纳与逐一排除，包括诊断与鉴别诊断，最后得出最可能的诊断结果（见图 4-1）。

4. 学会运用疾病概率的方法来进行推理和判断　概率是指一个特定事件（疾病）将要发生的可能性大小。疾病的诊断与鉴别诊断过程实质上是肯定疾病与排除疾病的过程，也是对患病可能性大小即患病概率的判断。概率诊断基于医生对患病率、发病率和自然病史的了解和经验。如果患病可能性为 100%，则肯定患病，单从诊断角度无须再进一步检查；如果患病可能性为 0，则可排除患病，也无须进一步检查。临床上患病概率一般介于两者之间，往往通过病史、症状、体征等进行推断。

概率推断举例：如一位 65 岁女性患者前来就诊。

患者：咳嗽很厉害。

医生：感冒的可能=80%，慢性支气管炎=15%，肺癌=5%。

患者：咳嗽时有痰，且有时带血丝；15 岁起吸烟，每天 2 包。

医生：感冒的可能=20%，慢性支气管炎=70%，肺癌=10%。

患者：近 3 个月来，咳嗽日益加重，且体重减少了 15kg。

医生:感冒的可能=1%,慢性支气管炎=19%,肺癌=80%。

5. 掌握对诊断假设进行验证的基本方法 全科医生的工作场所主要在社区,缺乏综合性医院的高级检查设备,因此,全科医生应努力从以下几方面着手验证诊断假设:①进一步询问病史,特别应针对几种需要鉴别的疾病假设,有目的、系统而深入地收集有助于鉴别诊断的相关信息,特别是疾病自然史和症状出现的规律或特征等方面的信息。此外,还应了解个人的完整背景、既往的健康状况、家庭成员的主要疾患及所在社区的疾病情况。②针对需要鉴别的疾病假设,有针对性地开展体检,以便发现一些隐藏的体征。③适当开展一些试验性治疗并对其干预效果进行追踪观察。④继续密切观察患者,等待发现更有价值的临床表现。⑤必要时可将患者转诊至上级医院行进一步检查,但应考虑这些检查的灵敏度、特异度、预测价值,尽量选择无创性、费用少而预测价值高的检查项目。⑥如有可能,寻求专科医生会诊。

6. 安全的诊断策略 全科医生应对的疾病错综复杂,不仅需要整体性的临床思维方式,还需要结合安全诊断策略。莫塔的临床诊断模型可以帮助全科医生解决临床常见问题,尽快识别急危重症疾病,并判断是否存在容易被忽略的问题。莫塔的诊断模型包括 5 个问题。

(1) 具有这种症状或体征的常见疾病有哪些? 全科医生长期在社区工作,对于社区的流行病学情况及患者病史非常熟悉,这是相较于其他专科医生的优势,可以更快地明确导致这种症状或体征的常见疾病,体现了“首先考虑常见病”的临床思维。

(2) 有什么重要的不能被忽略的严重疾病吗? 全科医生在诊疗中需要识别急危重症患者,尤其是那些易被忽略的严重和危及生命的疾病。如,急性心肌梗死是一种严重的具有潜在致命性的疾病,但当患者症状不典型(不表现为典型的心前区压榨样疼痛,而呈现出多部位不同程度和性质的疼痛,如下颌、颈部、上腹部疼痛等)时,易被医生忽视而造成严重后果。为了早期识别严重疾病,全科医生在诊疗中须建立“高度怀疑”意识,牢记首先排查急危重症疾病,这也体现了“严重疾病优先”的临床思维。

(3) 有什么容易被遗漏的病因吗? 全科医生在社区诊疗中有时面对的患者症状多,在临床上不易识别和诊断;或者因患者紧张、焦虑等,病史讲述不完整,导致存在漏诊的疾病。这就需要全科医生仔细询问患者病史,注意全身体检,根据整体性临床思维,结合病情,分析病案资料,寻找不易被识别的疾病或病因。

(4) 患者是否患有潜在的常被掩盖的疾病? 有些患者在讲述病史时因各种原因而隐藏一些信息,尤其是一些诊断不明确的未分化疾病,或者与精神心理、家庭等相关的问题。这需要全科医生加强临床实践,积累经验,关注疾病以外的问题;同时要善于倾听、富于关怀、有同理心,给患者提供恰当的能自由表达的机会。

(5) 患者是否试图告诉我什么? 作为一名全科医生,应与患者建立良好的医患关系,同时具备能敏锐察觉患者的需要和感受的能力,在面对患者,尤其是未分化疾病患者时,需要考虑患者此次就诊是否有“隐藏的目的”。在与患者进行有效沟通并取得其信任后,才能了解到患者内心的想法,这也体现出全科医生的职业素养和人文精神。

(二) 全科医生的诊疗流程

诊疗流程图是疾病诊断过程中常用的工具,通过构建诊断流程图可以帮助人们简明扼要地勾画出临床预防、诊断、治疗等关键环节与基本工作框架,为其提供思路清晰、逻辑性强、程序明确的临床工作流程和工具。

流程图(flowchart)在数学中有运算法则的内涵。区别于一般意义上的工作流程图(flow sheet 或 flow chart),全科医生诊疗流程图强调每前进一步都要求医生根据患者的具体情况加以认真地思考、“运算”,从而作出判断,而不是简单地依据流程与步骤依次行事、照方抓药。其特点是有明确的开始与结束,而中间是一系列过程及重要决策点,全科医生需要在关键决策点作出重要的决策判断(图 4-3)。在该流程图中,确定是否是急重患者是其关键步骤,这是全科医生在工作中必须首先作出判断的重要环节。确定为非急重患者后,仍需要根据流程图所示,进一步检查后再慎重地进行一次重复判

断。在判断是否需要进行转诊时，应制订明确的转诊指征，做好转诊前的必要准备工作。总之，全科医生的诊疗工作流程中应注意以下几方面内容。

1. 注意识别或排除可能会威胁患者生命的关键问题　在医疗卫生服务中，患者安全是第一要务。由于全科医生面对的大部分健康问题尚处于疾病的早期或未分化阶段，因此必须具备在疾病的早期阶段将严重的、威胁生命的关键问题识别出来，并及时进行转诊的技能。

2. 诊断鉴别分类和危险问题标识法　在接诊患者时，一定要在得出正确的诊断假设之前，根据病史和查体的结果判断患者病情的轻重缓急，特别要判断出是否为危、急、重患者，并随即进行相应处理（图 4-4）。对危急重患者可以利用危险问题标识法（red-flag approach），即在疾病鉴别诊断时，根据一定的症状、主诉、病史和其他临床线索，判断患者有无重要危险问题，这是一种很有效的方法。如，对于主诉乏力的患者，应用“red flags”提示乏力患者患有进行性或危及生命的疾病，如表 4-1 所示。

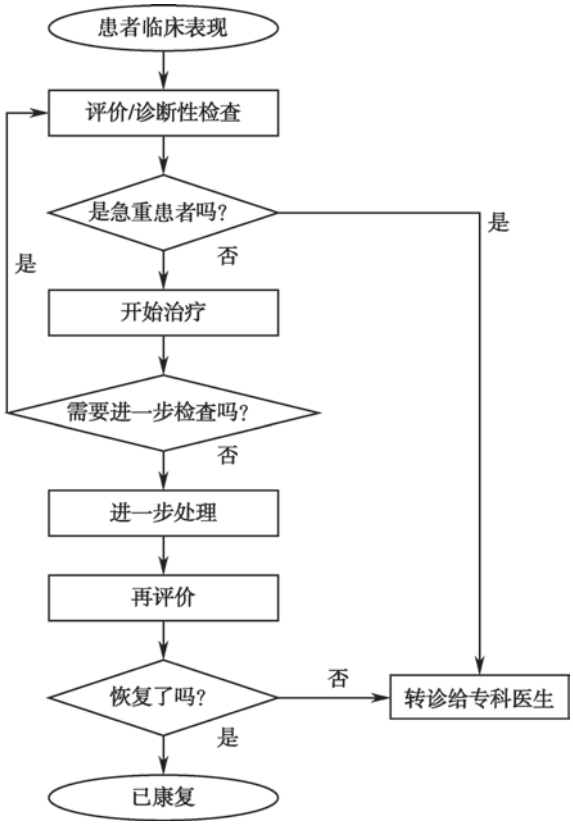


图 4-3　全科医生诊疗流程图

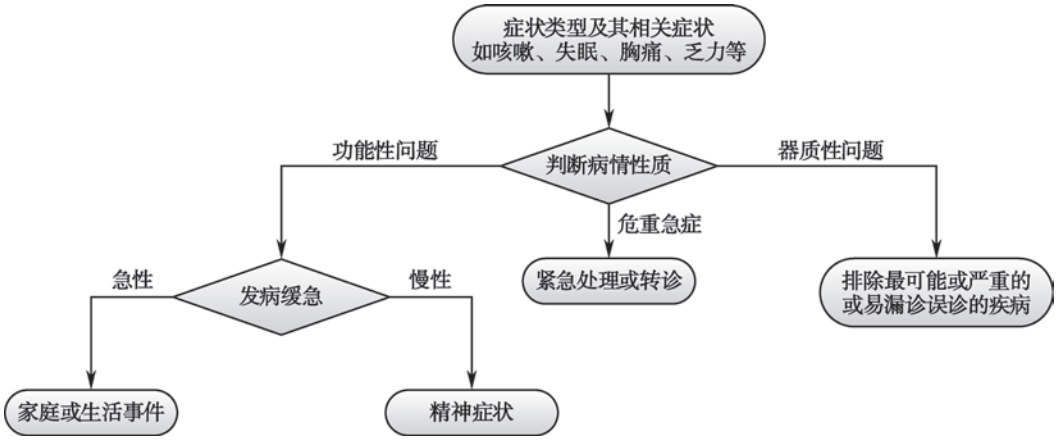


图 4-4　临床症状的诊断鉴别分类图

表 4-1　应用“red flags”提示乏力患者患有进行性或危及生命的疾病

诊断	“red flags”
重度抑郁症	出现自杀念头，社会活动减少、退缩
戒断综合征	有长期酒精、烟草或精神药物滥用史，最近突然停用
重症感染	体温 >39.5℃、脑膜炎、休克
严重心衰	端坐呼吸、心脏扩大、心脏杂音
控制不良的糖尿病	烦渴、多尿、体重下降

3. 其他问题的相关要求 对于已明确或怀疑有危险问题的患者应该及时进行转诊；对于留下来继续观察和治疗的患者，需要告知患者可能的结果。再确认患者明白后，为了进一步确定诊断，要连续观察患者的病情。在此过程中，一定注意不可漏掉重要的检查项目或拖延宝贵的时间，防止患者的健康甚至生命受到损害和威胁。

总之，全科医生在诊疗中应充分应用以病人为中心、以问题为导向、以证据为基础的临床思维模式，发挥优势，使患者、家庭及社会获得更多、更好的医学照顾。

（江孙芳）

思考题

1. 临床思维的要素有哪些？
2. 全科医学临床思维特征有哪些？
3. 社区常见健康问题的诊断策略是什么？

思考题解题思路　本章目标测试　本章思维导图